

Dokumentation. Für die Dokumentation ist neben der Durchführung der Pflegemaßnahme Folgendes festzuhalten:

- Zeitpunkt der Intervention,
- Zustand von Haaren und Kopfhaut: Besonderheiten und Veränderungen (z. B. auch vermehrter Haarausfall),
- Zustand des Betroffenen während und nach der Intervention, Tolerierung der Haarwäsche, ggf. nötige Unterbrechungen usw.,
- ggf. Blutdruck, Puls und neurologischer Status.

9.2.6 Rasur und Bartpflege

Die Rasur beinhaltet das Entfernen der täglich nachwachsenden Barthaare. Die Bartpflege beinhaltet das Waschen, Kämmen und Kürzen des Bartes. Bei der Rasur ist zwischen der Nassrasur und der Trockenrasur, d. h. der Rasur mit elektrischem Rasierapparat zu differenzieren. Eine Nassrasur gilt im Gegensatz zu einer Trockenrasur als gründlicher, erfordert aber mehr Geschick. Grundsätzlich richten sich die Form der Rasur sowie das Intervall nach den Wünschen des betroffenen Menschen.



Merke: Wegen der möglichen Verletzungsgefahr bei der Nassrasur, muss bei motorisch unruhigen Betroffenen sowie bei erhöhter Blutungsneigung z. B. bei Antikoagulantientherapie, Störungen der Blutgerinnung z. B. Hämophilie VIII und IX (Bluterkrankheit), der Elektrorasierer verwendet werden.

Zeitpunkt. In der Regel erfolgen die tägliche Rasur und die Bartpflege am Morgen im Zusammenhang mit den anderen Interventionen der Körperpflege. Der Zeitpunkt im Rahmen der Körperpflege richtet sich nach den individuellen Bedürfnissen der Betroffenen. Bei Personen, die Probleme bei der Nahrungsaufnahme haben, kann zudem eine Reinigung des Bartes nach den Mahlzeiten erforderlich sein.

■ Nassrasur

Material. Zur Durchführung der Rasur bzw. Bartpflege wird benötigt:

- Nierenschale oder Waschschißel als Wasserservoir für warmes Wasser,
- Handtuch und Waschlappen,
- Rasierschaum oder -creme,
- Rasierklinge/-messer und Rasierpinsel, Einmalrasierer,

- Rasierwasser, After-Shave oder Hautpflegemittel,
- Spiegel.

■ Durchführung

Der betroffene Mensch wird zur Durchführung der Rasur im Bett in die Oberkörperhochlage gebracht. Mobile Menschen werden auf der Bettkante oder am Tisch bzw. Waschbecken beim Einnehmen einer sitzenden Position unterstützt. Nach dem Anfeuchten des Gesichtes mit Wasser wird der Rasierschaum aufgetragen; er sollte kurz einwirken, damit die Barthaare aufweichen. Rasierschaum darf aus Sicherheitsgründen nicht direkt aus dem Spender in das Gesicht gegeben werden; er ist von den Händen in das Gesicht zu übertragen.

Rasiert werden kann gegen die Bartwuchsrichtung und mit der Bartwuchsrichtung. Befürworter der ersten Variante gehen von einer gründlicheren Entfernung der Barthaare aus, die andere Gruppe ist der Meinung, dass weniger Irritationen und Hautverletzungen gesetzt werden können. Der Rasierer ist zwischendurch mit klarem Wasser abzuspielen. Personen mit Zahnprothesen sollten diese vorher einsetzen, da eingefallene Mundpartien hierdurch weitestgehend verschwinden, die Rasur erleichtert und das Rasurergebnis verbessert wird.

Vorhandene Gesichtsfalten sind mit der Hand straff zuziehen bzw. zu spannen. Der Betroffene kann auch zu entsprechenden Gesichtsbewegungen aufgefordert bzw. gebeten werden, Gesichtsfurchen mit der Zunge von innen auszufüllen. Bei Hautunebenheiten ist Vorsicht geboten: Pickel dürfen nicht eingeschnitten werden. Personen mit der Diagnose einer halbseitigen Vernachlässigung, dem sog. Neglect-Syndrom, müssen beim Nachrasieren unterstützt werden, da die wahrnehmungsbeeinträchtigte Seite nicht oder nur unzureichend rasiert wird.

Die Effektivität einer Rasur kann mit dem Handrücken erfolgen: Wird die Gesichtsoberfläche als rau empfunden aufgrund noch vorhandener Barthaare, muss die entsprechende Gesichtspartie nachrasiert werden. Rasierschaumreste werden mit einem feuchten Waschlappen entfernt. Abschließend wird das Gesicht getrocknet und Rasierwasser, After-Shave oder ein Hautpflegemittel auf die rasierten Gesichtspartien aufgetragen. Der hohe Alkoholgehalt von 80–90% in Rasierwasser und After Shave dient zur Beruhigung der gereizten Haut und wirkt desinfizierend. Hinzu kommen duftkosmetische Gründe, die für die Anwendung dieser Mittel sprechen. Sie

sollten erst in die Hände des Betroffenen oder der Pflegeperson gegeben, und dann auf das Rasurgebiet aufgetragen werden.



Merke: Auch bei Barthaaren gilt, dass sie nur mit Einverständnis des betroffenen Menschen entfernt werden dürfen. Eine Notwendigkeit besteht z. B. bei geplanten Operationen im Gesicht.

Im Anschluss an die erfolgte Rasur werden die benutzten Materialien entsorgt und ggf. desinfiziert. Der betroffene Mensch wird bei der Einnahme einer angenehmen Lage unterstützt.

■ Trockenrasur

Eine Trockenrasur ist leichter und weniger aufwendig als eine Nassrasur. Die Barthaare müssen dabei trocken sein, da nasses Haar die Scherblätter verkleben kann. Der Barthaarschneider des Elektrorasiers wird zum Stutzen eines Bartes (z. B. Vollbart, Oberlippenbart, Kotletten) eingesetzt. Wie bei der Haarpflege kann auch zur Bartpflege ein Frisörtermin vereinbart werden.

Die Vorbereitung und Durchführung der Trockenrasur entspricht im Wesentlichen der bei der Nassrasur. Besondere Beachtung verdient die Reinigung und Desinfektion des Elektrorasiers.

Reinigung und Desinfektion des Elektrorasiers

- Zum Reinigen des Rasierapparates wird der Kopf des Gerätes geöffnet und abgenommen. Die Barthaare werden mit dem Reinigungspinsel entfernt; das Gerät anschließend wieder zusammengesteckt.
- Falls mehrere Personen ein Gerät benutzen, ist nach jedem Gebrauch eine Desinfektion vorzunehmen. Hierzu werden das abnehmbare Kopfteil und die Scherblätter in eine Desinfektionslösung eingelegt; der restliche Apparat wird wischdesinfiziert.



Zusammenfassung: **Haarpflege, Rasur und Bartpflege**

- Eine Haarwäsche sollte nicht durchgeführt werden bei: Wunden und Verletzungen im Bereich der Kopfhaut, erhöhtem intrakraniell Druck, Schädel-Hirn-Traumen und Halswirbelverletzungen. Virale

Infekte und Pneumonien sind bedingt als Kontraindikationen anzusehen.

- I. d. R. wird die Haarwäsche während des Badens oder Duschens durchgeführt. Ist beides nicht möglich findet die Haarwäsche im Bett oder am Waschbecken statt.
- Bei der Rasur ist zwischen der Nassrasur und der Trockenrasur zu unterscheiden.
- Die Form und das Intervall der Rasur richtet sich grundsätzlich nach den Wünschen des betroffenen Menschen.

9.2.7 Mund-, Zahn- und Prothesenpflege

Unter der Mund-, Zahn- und Prothesenpflege sind alle Maßnahmen der allgemeinen Mundhygiene zu verstehen. Hierzu zählen das Zähneputzen und Mundspülen, die Zungenreinigung sowie die Pflege von Zahnprothesen.

Ziele. Ziele der allgemeinen Mundhygiene sind:

- Reinigung von Zähnen, Zunge und Prothese,
- Feuchthalten der Schleimhäute sowie
- Karies- und Parodontitisprophylaxe.

Die Prothesenpflege entscheidet über eine intakte, saubere, belagfreie Zahnprothese und damit über den Erhalt von Prothesenfunktion und -aussehen. Maßnahmen der allgemeinen Mundhygiene dienen außerdem der Reinigung und dem Feuchthalten der Mundhöhle, insbesondere der Plaquebeseitigung an den Zähnen.

Zeitpunkt. Die allgemeine Mundhygiene sollte nach jeder Mahlzeit, mindestens aber 2–3-mal täglich erfolgen. Zusätzliche Durchführungen ergeben sich aus speziellen Situationen, wie z. B. Erbrechen.

■ Zahnpflege

■ Material

Zur Zahnpflege wird folgendes Material benötigt:

- Zahnbürste und -paste, Zahnseide, ggf. Interdentaltbürste, Munddusche, Mundwasser,
- Zahnputzbecher mit Spülflüssigkeit,
- Nierenschale, die zum Auffangen der Mundspülflüssigkeit (bei der Durchführung im Bett oder am Bettrand) dient,
- Handtuch zum Schutz und Abtrocknen,
- Holzspatel und Taschenlampe zur Inspektion der Mundhöhle, um eine optimale Einsicht und Beurteilung zu ermöglichen, sowie